

表2 単純X線での閉塞性無気肺の所見

縦隔および気管の偏位
横隔膜陰影の挙上（左では胃泡の挙上）
肺門陰影の偏位
葉間裂の偏位
代償性過膨張
肋骨の間隔の左右差（狭小化）
含気を失った陰影中の air bronchogram の消失
局所の肺野濃度の上昇
心陰影辺縁の消失
構造辺縁の不鮮明化（シルエットサイン）

流が多くシャントとなる場合には著しい低酸素血症をきたし、高流量酸素でも呼吸不全を治療できない場合には、気管挿管下の人工呼吸管理を含む呼吸不全への対応が必要である。

b 原因への対応

治療可能であれば原因への治療を行う。

- ・術後性無気肺（postoperative atelectasis）に対して

は、呼吸理学療法、体位ドレナージ、早期離床が重要であり、排痰困難例では気管支鏡による吸引を行うこともある。

- ・気管支粘液栓を含む気管支異物が原因の場合も気管支鏡による異物除去が必要となる。また、呼吸理学療法や体位ドレナージによる咯出も有効な場合がある。

ピットフォール

肺葉気管支が完全に閉塞しても無気肺を生じないことがある。しばしば葉間胸膜の仕切りが不完全であり、肺葉間にも側副気路が存在するためである。

文 献

- 1) 楠本昌彦，河野通雄：臨画像 11：86, 1995
- 2) 山口哲治ほか：臨放 42：135, 1997